

如果你考慮接受盆腔器官脫垂 (pelvic organ prolapse) 手術，你需要同外科醫生一齊做幾個重要決定。通常冇一個絕對「正確」嘅答案—最好嘅方案取決於你嘅身體結構、健康狀況，以及你最重視嘅係咩。呢份資料會帶你了解主要嘅決定，幫你同醫生有效溝通。

主要決定

- **修復 vs. 閉合**—重建支撐（修復性手術）並保持陰道暢通，或者閉合陰道（陰道閉合術，colpocleisis），適合唔打算再有陰道性行為嘅人。
- **手術路徑**—經陰道手術，或者經腹部微創/機械臂手術。
- **子宮嘅處理**—切除子宮（子宮切除術，hysterectomy），或者保留子宮並做懸吊術（子宮保留懸吊術，hysteropexy）。
- **支撐材料**—用你自己嘅組織（原生組織修復），或者用生物移植物，又或者用網片（如腹腔鏡骶骨固定術嘅人工網片）。
- **漏尿問題**—係咪同時加做防漏尿手術（見下方）。

關於隱性漏尿

有時候嚴重嘅脫垂會**遮住**壓力性尿失禁 (SUI)，呢種漏尿只會喺脫垂修復後先出現（「隱性」SUI）。你嘅醫療團隊可能會為你做測試，並討論係咪同時加做吊帶 (sling) 手術，或者等等先。

詞彙解釋

修復性手術

重建支撐，保持陰道正常功能。

閉合性手術

閉合陰道（陰道閉合術），效果持久，但會結束性行為。

子宮保留懸吊術

懸吊子宮嘅手術，保留子宮。

原生組織修復

只用你自己嘅組織修復，唔用任何移植物。

隱性 SUI

脫垂修復後先出現嘅隱性壓力性漏尿。

復發

脫垂日後再次出現嘅機會。

點樣做選擇？ 根據你嘅優先考慮來選擇—手術效果持久性、康復時間、保留子宮嘅意願、性生活需要，以及你對網片嘅看法。外科醫生會根據你嘅身體結構和健康狀況作出建議；喺清晰溝通後，最符合你目標嘅方案就係最好嘅選擇。

要問外科醫生嘅問題

- 你建議我做哪種**手術**？點解？
- **陰道路徑**還是**腹部路徑**—兩種方式各自嘅康復過程係點？
- 我係咪可以（或應該）**保留子宮**？
- 你會用**我自己嘅組織**、**移植植物**還是**網片**—各自有咩風險？
- 我而家需唔需要做**防漏尿**手術，定係之後先？
- **復發**嘅機會有幾大？如果復發點算？

其他重要資訊

- 如果你想避免或推遲手術，**子宮托 (pessary)** 係一個非手術替代方案。
- 控制體重、改善便秘和咳嗽，以及（停經後）使用陰道雌激素，可以改善手術效果。

點樣準備

- 完成所有**術前檢查**，並帶備完整藥物清單。
- 計劃**戒煙**，並安排家人在家協助。
- 了解一般康復原則：術後約 6 星期內避免重物和性行為。

手術前請告知你嘅醫療團隊，如果你：

- 服緊**薄血藥**或有出血問題
- 現時有尿道或陰道**感染**
- 有新出現嘅**盆腔痛、出血，或脫垂部位有傷口唔愈合**

要記住嘅三件事

1. 脫垂手術涉及多個選擇—修復還是閉合、手術路徑、係咪保留子宮、支撐材料，以及處理隱性漏尿。
2. 通常冇單一正確答案；最好嘅方案係配合你嘅身體結構同優先考慮。
3. 記得問關鍵問題，並記住子宮托係一個非手術嘅替代選擇。